認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護5
認定日	令和8年10月9日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年3月31日(新規・6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月5日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	新規申請		
対象者氏名	青木 和子 (あおき かずこ)	性別	女
生年月日	昭和22年(1947年)7月7日	年齢	79歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付(暫定ケアプランで利用開始) 訪問介護(身体介護・毎日2回)、訪問入浴介護(週1回)、福祉用具貸与(特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具)。医療 訪問診療(週1回)、訪問看護(週3回・疼痛管理と点滴の管理)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	夫(81歳)と二人暮らし。長女(50歳)が近くに住み、毎日来て夫と一緒に介護している。
居住環境	2階建て持ち家。1階の居間に介護ベッドを置いて過ごしている。
使用している機器等	特殊寝台、床ずれ防止用具(エアマット)、オピオイドの持続皮下注射ポンプ(訪問看護が管理)、紙おむつ。
生活歴	小学校の教員として定年まで勤めた。書道が趣味で、自宅で子ども向けの書道教室を開いていた。
本人・家族の主訴	本人:「最期は住み慣れたこの家で、家族と過ごしたい。痛いのはいや。」 夫・長女:「本人の希望どおり家で看取りたい。急に様子が変わったときが不安。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-5 座位保持	できる　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる (できない)
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-7 歩行	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助 (全介助) 行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助 (全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-2 移動	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-3 えん下	できる (見守り等) できない
2-4 食事摂取	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-6 排便	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-7 口腔清潔	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-8 洗顔	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-9 整髪	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-12 外出頻度	週1回以上　月1回以上 (月1回未満)
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる) ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる) できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる) できない
3-4 短期記憶	(できる) できない
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	(できる) できない
3-7 場所の理解	(できる) できない
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない) ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない) ときどきある　ある
4-2 作話	(ない) ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない) ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない) ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない) ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない) ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない) ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない) ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない) ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない) ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない) ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない) ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない) ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない) ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない) ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる))　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない) ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

■点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　■疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　A2　B1　B2　C1　(C2)
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　(Ⅰ)　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-3〜1-9 全身の衰弱と痛みのため、自分では寝返りもできない。2時間ごとに家族と訪問介護員が体の向きを変えている。 1-10 訪問入浴で、看護師が状態を確認しながら全身を洗う。
第2群 生活機能	2-1・2-2 ベッドから離れることはない。 2-3・2-4 口から食べられるのは、ゼリーや水分を少量。家族がスプーンで介助する。 2-5・2-6 おむつを使用。 2-12 ベッド上で過ごし、外出はしていない。
第3群 認知機能	3-1〜3-7 すべて答えられた。ぼんやりする時間が増えてきたが、話しかけるとはっきり答える。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。
第5群 社会生活への適応	5-1 痛み止めの持続皮下注射は訪問看護師が管理し、内服薬は夫が飲ませている。 5-2 金銭は夫が管理している。 5-3 治療や過ごし方について、自分の希望をはっきり伝えている。
特別な医療	点滴の管理:皮下輸液(1日500mL)を訪問看護師が管理している。 疼痛の看護:がんの痛みに対し、オピオイドの持続皮下注射を行い、訪問看護師が痛みの評価と量の調整を行っている。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	青木 和子 (女・79歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 膵臓がん(多発肝転移)	令和8年3月
2. がん性疼痛	令和8年7月
(2)症状としての安定性	不安定
(3)経過及び治療内容	令和8年3月に膵臓がん(多発肝転移)と診断。本人の希望で積極的な治療は行わず、緩和ケアの方針。9月下旬から全身状態が急に悪化し、経口摂取が少量となった。予後は1〜2か月と考えられ、本人・家族は自宅での看取りを希望している。 処置・投薬:オピオイドの持続皮下注射、皮下輸液(1日500mL)、制吐薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

点滴の管理、疼痛の看護

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):C2 認知症高齢者の日常生活自立度: Ⅰ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	なし(せん妄の兆候に注意)
(5)身体の状態	利き腕:右/身長152cm・体重36kg(半年で10kg減少)/全身の衰弱/腹部の痛み/褥瘡なし(仙骨部の発赤に注意)

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない/車いす:用いていない/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:一部介助/栄養状態:不良/留意点:食べたい物を食べたいときに、少量ずつ
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	疼痛の増強、褥瘡、せん妄、急な状態変化 → 訪問診療・訪問看護による症状緩和、24時間の連絡体制、家族への看取りの説明
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できない
(5)医学的管理の必要性	訪問診療、訪問看護(24時間対応)
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	痛み:体位変換の前に痛みの程度を確認/皮膚:発赤の観察/その他:状態変化時は訪問看護に連絡
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

末期がんによる看取り期で、症状は日々変化している。訪問診療・訪問看護と介護サービスが連携し、本人・家族の希望する自宅での看取りを支える体制が必要。